EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 84423
SERVICIO	: MEDICINA HSC		
FECHA	: 2024-05-13 12:34:00		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARGARITA ROSA RODRIGUEZ DIAZ			RUN	: 7.284.339-8
F.Nac	: 26-04-2024	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-04-26	Fecha Egreso	: 2024-05-13 12:34:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) SDRA global resuelto
2) Fibrosis pulmonar
3) EPOC exacerbado tratado
4) HTA
5) Obesidad

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J43.9-ENFISEMA, NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PAciente con antec descritos, consulta en primera instancia en SU HSC el 06/04 en contexto de 5 dias de evolucion de tos no productiva, disnea a minimos esfuerzos, algia toracica tipo pleuritico, con irradaicion hacai region dorsal, estuvo en terapia ATB desde APS desde el 24/04 (no se describe terapia ATB recibida). Se decide ingreso, durante estadia en regulares condiciones, taquipneica, desaturando, con reqeurimiento de O2 suplemnetario con FiO2 al 36%; , examenes de lab al ingreso se describe leucocitocis, parametros inflamatorios elevados, TAC de torax al ingreso con patron intersticial difuso, fibrosis pulmonar y patron de vidrio esmerilado inespecifico, sugerente de infecion. Paciente en servicio evoluciona con mayor disnea, mayor requerimiento de O2 suplementario por MAF hasta 75%, polipnea, GSA con PAFI 180, se inicia manejo con broncodilatacion y corticoides, sin respuesta, se procede a traslado a UCI para contoniar con manejo,
EN UCI se apoya con CNAF, evolucionando con mala mecanica ventilatoria, con uso de musculatura accesoria, se procede a VMI por 5 dias, saliendo a naricera tras weaning, sin mala mecanica ventilatoria, HDN estable, desde esfera infecciosa con panel viral respiratorio (-), sin CSB debido a escasa secrecion bronquial, se completa terapia ATB con ceftriaxona y azitromicina, sin inconvenientes. Tras weaning se decide traslado a UTI
Ingresa a UTI el 05/05, con hemodinamia estable, ventilando espontaneo, con reqeurimiento de O2 suplementario con FiO2 al 28%; tos productiva abundante, se toma CSB. SE mantiene afebril, con aprametros inflamatorios bajos, funcion renal conservada, se decide traslado a medicina.

Paciente HDN estable, afebril, sin dolor, con buena respuesta tras retiro de O2 suplementario ayer a las 17 hrs (saturaciones fluctuantes entre 90 - 92%), con buena tolerancia a alimentacioN VO; sin episodio de nauseas y/o vomitos, diuresis 400 cc, deposiciones 150 cc.

Examenes de lab 13/05 -> crea 0,8; lactato 0,9; PCR 5; Na/K/Cl 137/3.1/104; Hb/Hcto 14.8/43.1; Gb 11.8; plaq 271000; segment 71%; INR 1,03; dimero D 613.1; GSA pH 7,5; pCO2 28,1; pO2 70,4; PAFI 335

Ex fisico -> Vigil; CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen BDI, RHA (+´), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Actualmente cursando su dia N° 16 hospitalizado, dia N° 6 de hospitalizacion en medicina, en condiciones de traslado a HODOM para KNT rehabilitadora

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Actualmente con buena respuesta tras retiro de O2 suplementario, se continuara con KNT rehabilitadora via HODOm
3) Infeccioso/Respiratorio: Con mejoria clinica considerable en comparativa a ingreso, sin conflicto actual

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentada 30°
2. Regimen liviano a tolerancia
3. Salbutamol 2 puff c/6hrs por 7 dias
4. Budesonide 2 puff c/12 hrs por AC por 7 dias
5. Salmeterol/Fluticasona 250/25, 2 puff c/12 hrs por AC por 7 dias
6. KNT motora y respiratoria dos veces al dia

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO